Zeitliche Erosion der Solidarität

Wie Solidarität über die Zeit von "Ich halte zu dir" zu "Ich muss ständig absichern" wird

3-PHASEN-MODELL

PHASE 1: FRÜHPHASE (nach Diagnose/ersten Episoden)

- **Wie sich Belastung anfühlt:** Notfallmodus, Rollenverschiebung: Der gesunde Partner wird zum Krisenmanager, organisiert Behandlung, übernimmt Verantwortung
- **Wie Solidarität kippt:** Solidarität wird zur Funktion ("organisieren, stabilisieren"). Nähe und emotionale Verbundenheit können in den Hintergrund treten, die Beziehung wird funktional

PHASE 2: WIEDERKEHRENDE EPISODEN

- **Wie sich Belastung anfühlt:** Zyklus aus Hoffnung/Normalisierung und erneuter Krise, oft mit starker Unsicherheit. Partner erleben einen Wechsel zwischen "Es wird besser" und "Schon wieder"
- **Wie Solidarität kippt:** Jede Episode erzeugt Folgelasten (z.B. Vertrauensbrüche in manischen Phasen, finanzielle Schäden, sexuelle Probleme), die kumulativ wirken. Die Hoffnung auf dauerhafte Besserung schwindet

PHASE 3: CHRONISCHE MANAGEMENTPHASE

- **Wie sich Belastung anfühlt:** Die Hauptlast wird "Krise antizipieren": Dauer-Alarmbereitschaft, Schlafprobleme, chronische Erschöpfung, emotionale Entfremdung
- **Wie Solidarität kippt:** Solidarität wird innerlich teurer: Sie muss gegen Angst, Groll, Müdigkeit und Selbstschutz-impulse “verteidigt” werden. Partner fühlen sich zerrissen zwischen Bleiben-Wollen und Nicht-Mehr-Können

WAS STABILISIERT SOLIDARITÄT?

→ **Warnzeichen** gemeinsam definieren
→ **Wenn-dann-Regeln** vereinbaren
→ **Sicherheitslinien** ziehen (z.B. keine finanziellen Großentscheidungen in manischen Phasen)
→ **Entlastung** durch **tragfähiges Netz** (Familie, Freunde, Selbsthilfegruppen)
→ **Regelmäßige Auszeiten** für Partner

Basierend auf: Borowiecka-Karpiuk et al. (2014); Schmid et al. (2005); Granek et al. (2016)
Konzeptuelle Synthese für psychoedukative Zwecke